



PCMSO

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

(Portaria MTP n.º 567, de 10 março de 2022)

CRA - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Matriz

Abril/2026

**ÍNDICE GERAL**

1 - Identificação da Empresa	3
2 - Objetivos	4
3 - Responsabilidades	5
4 - Programação de Exames Clínicos	6
5 - Programação de Exames Complementares	13
5.1 - OPERACIONAL	
5.1.1 - PROFISSIONAL NÍVEL I	13
5.1.2 - PROFISSIONAL NÍVEL II	15
5.1.3 - TRABALHADOR AGROPECUÁRIO POLIVALENTE	17
6 - Elaboração de Programas Especiais	19
7 - Recomendações à Empresa	21
7.1 - Orientações e Conduta a Prevenção da COVID-19	22
8 - Considerações Finais	24
9 - Nomeação de Médicos Avaliadores	27
10 - Encerramento e Protocolo	28
11 - Anexos	30



1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: *CRA - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA*

Endereço: Alameda QUADRA ASR SE 75 ALAMEDA 2, SN LOTE 51 QI 10 -
PLANO DIRETOR SUL - Palmas/TO - CEP:77022-426

Telefone: ()

Atividade: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CNAE: 82.11-3-00

Grau de Risco: 1 (um)

CNPJ: 51652760000114

Inscrição Estadual:

Nº de Empregados: 6 (seis)

Data: 7 de Abril de 2026

Validade: 12 (doze) meses

Local de atividade

CNPJ: 51.652.760/0001-14 - Matriz - Grau de Risco: 1 (um)

Alameda QUADRA ASR SE 75 ALAMEDA 2, SN LOTE 51 QI 10 - PLANO
DIRETOR SUL - Palmas / TO - CEP: 77022-426

O Levantamento das condições ambientais foi realizado pela(o) Eduardo
Martins de Souza Leite

2 - OBJETIVOS

Objetivo.

O presente programa tem como objetivo promover a saúde dos trabalhadores, prioritariamente de forma preventiva, rastreando e diagnosticando precocemente os agravos de saúde relacionados ao trabalho, doenças profissionais já manifestadas ou ainda subclínicas, e eventuais danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. A Implantação do PCMSO deverá levar em consideração os riscos à saúde dos trabalhadores e a cultura acidentaria da Empresa.

▪

3 - RESPONSABILIDADES

3.1 - São as seguintes as responsabilidades do empregador pertinentes ao P.C.M.S.O.:

- a) Garantir a elaboração e a efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia;
- b) Custear sem ônus para os empregados, todos os procedimentos relacionados ao P.C.M.S.O. inclusive programas especiais;
- c) Encaminhar para realizações dos exames clínicos e complementares solicitados neste P.C.M.S.O. bem como quaisquer, outras ações preventivistas solicitado pelo Médico Coordenador.

3.2 - São as seguintes as responsabilidades do Médico Coordenador do P.C.M.S.O.:

- a) Realizar os exames médicos previstos no item 7.4.1., ou encarregar os mesmos a profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e sua causas, bem como, com o ambiente, as condições de trabalho, e os riscos a que esta ou será exposto cada trabalhador da empresa à ser examinado;
- b) Encarregar dos exames complementares previsto nos itens, e quadros e anexos desta NR, profissionais e ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados.

4 - PROGRAMAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS

Exames Clínicos

OBS: Fica ressaltado que todos os colaboradores que trabalham em altura necessitam realizar os exames específicos da NR-35 Norma Regulamentadora.

Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que:

a) Os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional PCMSO, devendo estar nele consignados;

b) A avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação;

Sob o ponto de vista médico os exames médicos deverão compreender, além dos principais fatores que causam as quedas de planos elevados como condições físicas, psíquicas e clínicas do trabalhador, os demais fatores da tarefa como, por exemplo, exigência de esforço físico, acuidade visual, restrição de movimentos, etc.

c) Seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais.

Algumas patologias poderão originar mal súbito e queda de altura:

- Epilepsia
- Vertigem e tontura
- Distúrbios do equilíbrio e deficiência da estabilidade postural
- Alterações cardiovasculares
- Acrofobia
- Alterações otoneurológicas
- Diabetes Mellitus

Além da existência da acrofobia (medo de altura) devem ser avaliados outros fatores que interferem na saúde do trabalhador como alimentação inadequada, distúrbios do sono, consumo de bebidas alcoólicas, problemas familiares, stress, uso de fatores psicossociais.

A urgência de maior produtividade, associada à redução contínua do contingente de trabalhadores, à pressão do tempo e ao aumento da complexidade das tarefas, além de expectativas irrealizáveis e as relações de trabalho tensas e precárias, podem gerar tensão, fadiga e esgotamento profissional, constituindo-se em fatores psicossociais responsáveis por situações de estresse relacionado com o trabalho.

Os fatores psicossociais relacionados ao trabalho podem ser definidos como aquelas características do trabalho que funcionam como “estressores”, ou seja, implicam em grandes

exigências no trabalho, combinadas com recursos insuficientes para o enfrentamento das mesmas.

A aptidão para trabalho em altura deverá ser consignada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador.

Além de constar apto para a função a aptidão para o trabalho em altura também deverá estar registrada no Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

Os exames complementares deverão ser realizados por todos os trabalhadores que exercem atividades em altura independentemente dos exames já especificados no PCMSO da Empresa:

Planejamento e Medidas Gerais.

O PCMSO entre outras atividades deve incluir a realização obrigatória dos seguintes exames Médicos:

- a) Admissional
- b) Periódico
- c) de retorno ao trabalho
- d) de mudança de risco ocupacional
- e) demissional

Obs.: Os exames acima citados compreendem avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e clínica, exame físico e mental, exames laboratoriais, radiológicos, provas funcionais, etc.

Exame admissional.

Este exame será realizado sempre antes que o candidato assuma o seu posto de trabalho: suas condições físicas, clínicas e mentais serão avaliadas em função dos riscos ambientais a que será exposto para as definições da sua aptidão. Agravos de saúde ocupacionais pré-existentes serão investigados, visando o seu tratamento, ou no mínimo impedir que se agrave.

Exame periódico

Será realizado anualmente em todos os colaboradores, visando diagnosticar precocemente qualquer agravo de saúde seja ocupacional ou não, e especialmente monitorar eventuais

problemas encontrados, impedindo que se agravem.

Exame de retorno ao trabalho.

Será realizado sempre que o funcionário se afaste da função mais de trinta dias, seja por doença de natureza ocupacional ou não, acidente de trabalho ou parto.

Exame de mudança de risco ocupacional

Deverá ser realizado em todo funcionário que tiver, mudança no seu posto de trabalho, que implique em novos e diferentes riscos, a que não estava exposto anteriormente. Visa, portanto, avaliar sua aptidão ao novo risco, e será sempre realizado antes que ele assuma a nova função.

Exame demissional

Este exame visa avaliar a integridade física e mental do funcionário ao sair da Empresa, detectando eventual doença profissional, ou seqüela de acidente de trabalho, que possa torná-lo inapto para continuar exercendo a mesma função em outras empresas.

Emissão de Atestado de Saúde Ocupacional ASOs.

Atendendo à legislação, para todos os exames acima relacionados, serão emitidos ASOs (Atestado de Saúde Ocupacional) em duas vias, sendo uma cópia entregue ao funcionário, e a outra arquivada no departamento de administração de pessoal da Empresa, a disposição do agente de inspeção do trabalho.

Prontuário Clínico Individual dos Colaboradores.

Durante a implantação do PCMSO, a na primeira avaliação clínica do candidato ou funcionário, será preenchido um prontuário que conterà as suas informações clínicas, tais como: dados de anamnese, antecedentes ocupacionais, exame físico, resultados de exames complementares, conclusões e recomendações dadas ao funcionário, ou a sua chefia, etc.

Programas de prevenção de doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, e de promoção da saúde bem estar físico e mental dos colaboradores.

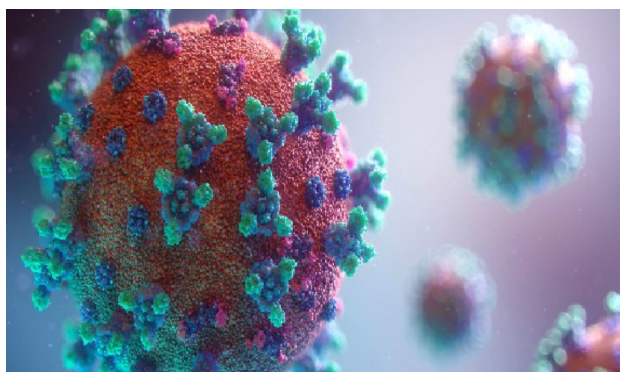
Treinamento para prevenção de doenças de coluna lombar e de LER lesão por esforços físicos

Através de palestras com recursos audiovisuais

Programa de Prevenção de PAINPSE (Perda Auditiva Induzida por Nível de Pressão Sonora Auditiva).

Será realizado Audiometria inicial em todos os colaboradores, expostos a níveis de pressão sonora superior à 80 decibéis, realizando anualmente; exceto para colaboradores em que seja detectado agravamento da PAIR, e que neste caso, serão acompanhados semestralmente e se necessário afastados da exposição. Todos os colaboradores expostos a pressão sonora maior que 80 dB, deverão usar obrigatoriamente EPI auricular.

Orientações serão necessários, para conscientização da importância do uso do EPI auricular.



Programa de Prevenção para mitigar a exposição ao Risco COVID- 19 no ambiente de trabalho.

A transmissão da SARS CoV-2 ocorre de humanos para humanos por contato de gotículas respiratórias (tosse, espirro, catarro), pela saliva oriunda de pessoas infectadas pelo vírus ou contato com superfícies contaminadas seguido de contato com a boca, nariz e olhos. O período de incubação da infecção por COVID-19, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), varia de 1 a 10 dias, geralmente ficando a média em torno de 5 dias.

Os sinais e sintomas da Doença COVID-19, são abaixo relacionados: Febre ($>37,8^{\circ}\text{C}$); Tosse; Dispnéia; Mialgia e fadiga; Sintomas respiratórios de VAS; Sintomas gastrointestinais (diarreia).

Quanto ao quadro clínico, trata-se de uma típica Síndrome Gripal, onde pode ocorrer variações desde uma apresentação de sintomas leves ou ser assintomática até uma apresentação grave, qual seja uma pneumonia e até uma Síndrome da Angústia Respiratória Aguda - SARA. A anosmia tem sido uma queixa frequente entre os pacientes acometidos da COVID-19.

Diagnóstico laboratorial:

O teste “padrão ouro” de diagnóstico é o RT-PCR - Real Time Polymerase Chain Reaction para COVID-19, sendo o mais adequado por ser mais assertivo, com sensibilidade mais elevada desde os primeiros dias de infecção. Importante salientar que a sensibilidade do exame varia de acordo com a data da coleta do exame sendo maior entre o 3º e 7º dia de sintomas. Após o 7º dia a sensibilidade começa a cair, atingindo a 45% após 15 dias da doença.

RT-PCR (biologia molecular) é capaz de detectar a carga viral, a presença do material genético do vírus na secreção respiratória dos pacientes. O exame é realizado em material coletado de secreção de naso/orofaringe. Por meio de técnicas de biologia molecular, quantifica o material genético do vírus na amostra do paciente.

Indicação:

Paciente sintomático moderado/grave com critérios clínicos/radiológicos de internação hospitalar, para diagnóstico de COVID-19 e definição de leito de isolamento.

Profissional de saúde sintomático para definição de afastamento laboral (RT- PCR positivo)

Para pacientes com síndrome gripal, sem critérios clínicos ou fatores de risco para internação hospitalar, para diagnóstico de COVID-19.

Sorologia (Testes sorológicos) são testes imunológicos capazes de detectar os níveis de anticorpos IgM e IgG em amostra de sangue venoso do paciente, por imunoensaio automatizado. De forma geral, observou-se um aumento de anticorpos após 7 a 10 dias. Sensibilidade do teste é variável de acordo com os fabricantes estando entre 70 % e 100% para IgM e 85% a 96% para IgG.

A sorologia, no entanto, possui baixo valor preditivo negativo e, por isso, um resultado negativo não exclui a presença da doença. A presença de anticorpos da classe IgG para definição da imunidade adquirida ocorre com melhor sensibilidade após o 15º dia de início dos sintomas.

Menos de 40% dos pacientes tem anticorpos detectáveis durante os primeiros 7 dias do início dos sintomas.

Um resultado não reagente por métodos sorológicos não descarta a possibilidade da COVID-19, principalmente nas fases iniciais da doença e não deve ser usado como única base para decisão diagnóstica e para interrupção do isolamento.

Resumo:

RT-PCR	Sorologia IgA/IgM	Sorologia IgG	Interpretação
Negativo	Negativo	Negativo	Sem história de infecção atual ou pregressa
Negativo	Positivo	Negativo	Sugestivo de infecção atual recente (> 7 a 10 dias de sintomas clínicos)
Negativo	Neg ou Pos	Positivo	Sugestivo de infecção prévia ou atual recente (> 7 a 10 dias)
Positivo	Negativo	Negativo	Sugestivo de infecção atual (<7 dias)
Positivo	Positivo	Negativo	Sugestivo de infecção atual (5 a 10 dias)
Positivo	Neg ou Pos	Positivo	Sugestivo de infecção atual recente (>7 a 10 dias)

A interpretação sugerida é baseada na avaliação de valores positivos e negativos verdadeiros de cada exame. Possibilidade de resultados falso-negativos de PCR e sorologia devem ser considerados no contexto clínico de cada indivíduo.

Avaliação para retorno ao trabalho:

Deve-se utilizar critérios clínico/ epidemiológico e laboratorial. Assim sendo, observar:
Critério clínico/epidemiológico: 72 horas assintomático (sem usar antitérmico) e estar entre 7 a 10 dias do início dos sintomas.

- Critério laboratorial: RT-PCR negativo + atender critério clínico epidemiológico. Poderá retornar ao trabalho. RT-PCR positivo.
- Manter o trabalhador 14 dias afastado. Sorologia negativa, deve fazer o RT- PCR. Sorologia positiva para IgA ou IgM, deve manter o trabalhador 14 dias afastado.

Manejo diagnóstico de casos suspeitos pelo Médico do Trabalho:

1. Estabelecer fluxo de atendimento aos trabalhadores, com sala própria e isolada, bem arejada, sem ar condicionado, adotando os protocolos de segurança instituídos pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento do COVID-19
2. Identificação de caso suspeito de Síndrome Gripal e de COVID-19
3. Deve ser especificado em prontuário
4. As medidas para evitar contágio estão pormenorizadas abaixo (Quadro 1)⁵ : Fornecer máscara cirúrgica ao paciente
5. Avaliação da gravidade da Síndrome Gripal
6. Casos leves: manejo terapêutico sintomático e isolamento domiciliar
7. Casos graves: encaminhamento para serviços hospitalares de referência. Verificar a necessidade de chamar o SAMU.

Exame	Função	Periodicidade (meses) por Faixa Etária			Observação
		< 18	18 a 45	> 45	
Clínico	Todas	12	12	12	conforme último exame

5 - PROGRAMAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Setor:	5. 1 - OPERACIONAL - GHE 1									
Função:	5.1.1 - PROFISSIONAL NIVEL I									
Cargo:	PROFISSIONAL NIVEL I									
Jornada		Repouso		Nº. Funcionários		Faixa Etária				
				Homem	Mulher	< 18	18 a 45	> 45		
8		2		2	0	0	0	0	2	
Descrição da Função										
Acabar pavimentos; demonstrar competências pessoais; drenar solos; executar construção de aterros; operar máquinas pesadas; planejar o trabalho; realizar manutenção básica de máquinas pesadas; remover solo e material orgânico "bota fora. Almoxarife, Apropriador, Armador, Auxiliar de Topografia, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar Pessoal, Auxiliar Mecânico, Auxiliar de Lubrificação, Besourista, Borracheiro, Bombeiro, Carpinteiro, Encadernador, Ficheiro, Eletricista Industrial, Eletricista Auto, Eletricista, Impermeabilizador, Jeriqueiro, Ladriheiro, Lubrificador, Maçariqueiro, Marcenheiro, Operador de Máquina Pesada, Montador, Operador Britador, Operador de Caminhão, Operador Esparginhador, Operador de Grua, Operador Mini Carregadeira, Operador Painel, Operador Guindaste, Operador Rock, Operador Rolo Asfáltico, Operador Usina de Asfalto, Operador de Pavimentação, Perfurratriz, Fresadora, Operador Concreto, Operador Vibro Acabadora, Pastilheiro, Pedreiro, Pintor, Pinstor de Sinalização Asfáltica, Rasteleteiro, Sinaleiro, Soldador, Torneiro Mecânico e Tratorista de Pneu.										
EXAMES NECESSÁRIOS										
Risco	Agente	Fonte Geradora	Exame	Periodicidade	Adm.	Após Adm.	Per.	Ret. Trab.	Mud. Risco	Dem.
--	--	--	Acuidade visual	12 meses	X	--	X	X	X	
--	--	--	Audiometria tonal	12 meses	X	--	X	X	X	X
--	--	--	Avaliação Clínica Ocupacional	12 meses	X	--	X	X	X	X
Acidente										
Agente		Fonte Geradora			Danos à Saúde			Medidas de Controle		
Batida Contra, Tombamento		Ato de dirigir			Lesões			Seguir normas de Trânsito		
Queda de Diferença de Nível		Trabalho em Altura						Uso de EPI´ S		
Torções/Tropeços		Ambiente de trabalho						Uso de EPI´ S		

Ergonômico			
Agente	Fonte Geradora	Danos à Saúde	Medidas de Controle
Trabalho com esforço físico intenso	Levantamento manual de peso	Lesões Musculares, Lesões Articulares, Fraturas Ósseas, Lesões Cardíacas, Queda Da Imunidade, Irritabilidade, Insônia, Quedas.	Pausas regulares
Físico			
Agente	Fonte Geradora	Danos à Saúde	Medidas de Controle
Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Insolação	Uso de protetor solar e Uso de EPI' S
Ruído contínuo ou Intermitente	Máquinas	Provoca Cansaço, Irritação, Dores De Cabeça, Diminuição Da Audição (Surdez Temporária, Surdez Definitiva E Trauma Acústico), Aumento Da Pressão Arterial, Problemas No Aparelho Digestivo, Taquicardia, Perigo De Infarto.	Uso de EPI' S
Temperaturas anormais (calor)	Trabalho a céu aberto	Taquicardia, Aumento Da Pulsação, Cansaço, Irritação, Choques Térmicos, Fadiga Térmica, Perturbações Das Funções Digestivas, Hipertensão.	Uso de EPI' S
Vibração de corpo inteiro	Motor das Máquinas	Cansaço, Irritação, Dores Nos Membros, Dores Na Coluna, Doença Do Movimento, Artrite, Problemas Digestivos, Lesões Ósseas, Lesões Dos Tecidos Moles, Lesões Circulatórias.	Pausa regulares
Químico			
Agente	Fonte Geradora	Danos à Saúde	Medidas de Controle
Petróleo e seus derivados	Contato com material derivados de petróleo	Dermatites, queimaduras, náuseas, dores de cabeça, tonturas e problemas respiratórios.	Uso de EPI' S

Setor:	5. 1 - OPERACIONAL - GHE 1									
Função:	5.1.2 - PROFISSIONAL NÍVEL II									
Cargo:	PROFISSIONAL NÍVEL II									
Jornada		Repouso		Nº. Funcionários		Faixa Etária				
				Homem	Mulher	< 18	18 a 45	> 45		
8		2		3	0	0	1	2		
Descrição da Função										
Acabar pavimentos; demonstrar competências pessoais; drenar solos; executar construção de aterros; operar máquinas pesadas; planejar o trabalho; realizar manutenção básica de máquinas pesadas; remover solo e material orgânico "bota fora. (Eletricista Alta tensão, Operador de máquina de pintura Asfáltica, Operador de Guindaste acima de 30 Toneladas, Operador de Motoscraper, de motoniveladora, de pá Mecânica, de Patrol, de Pá Carregadeira, de Trator Esteira, de Retroescavadeira, de Escavadeira Hidráulica, Encarregado Armador, Encarregado de Campo, Encarregado de Usina de Asfalto, Laboratorista e Topógrafo).										
EXAMES NECESSÁRIOS										
Risco	Agente	Fonte Geradora	Exame	Periodicidade	Adm.	Após Adm.	Per.	Ret. Trab.	Mud. Risco	Dem.
--	--	--	Acuidade visual	12 meses	X	--	X	X	X	
--	--	--	Audiometria tonal	12 meses	X	--	X	X	X	X
--	--	--	Avaliação Clínica Ocupacional	12 meses	X	--	X	X	X	X
Acidente										
Agente		Fonte Geradora			Danos à Saúde			Medidas de Controle		
Batida Contra, Tombamento		Ato de dirigir			Lesões			Seguir normas de Trânsito		
Queda de Diferença de Nível		Trabalho em Altura						Uso de EPI´ S		
Torções/Tropeços		Ambiente de trabalho						Uso de EPI´ S		

Ergonômico			
Agente	Fonte Geradora	Danos à Saúde	Medidas de Controle
Trabalho com esforço físico intenso	Levantamento manual de peso	Lesões Musculares, Lesões Articulares, Fraturas Ósseas, Lesões Cardíacas, Queda Da Imunidade, Irritabilidade, Insônia, Quedas.	Pausas regulares
Físico			
Agente	Fonte Geradora	Danos à Saúde	Medidas de Controle
Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Insolação	Uso de protetor solar e Uso de EPI' S
Ruído contínuo ou Intermitente	Máquinas	Provoca Cansaço, Irritação, Dores De Cabeça, Diminuição Da Audição (Surdez Temporária, Surdez Definitiva E Trauma Acústico), Aumento Da Pressão Arterial, Problemas No Aparelho Digestivo, Taquicardia, Perigo De Infarto.	Uso de EPI' S
Temperaturas anormais (calor)	Trabalho a céu aberto	Taquicardia, Aumento Da Pulsação, Cansaço, Irritação, Choques Térmicos, Fadiga Térmica, Perturbações Das Funções Digestivas, Hipertensão.	Uso de EPI' S
Vibração de corpo inteiro	Motor das Máquinas	Cansaço, Irritação, Dores Nos Membros, Dores Na Coluna, Doença Do Movimento, Artrite, Problemas Digestivos, Lesões Ósseas, Lesões Dos Tecidos Moles, Lesões Circulatórias.	Pausa regulares
Químico			
Agente	Fonte Geradora	Danos à Saúde	Medidas de Controle
Petróleo e seus derivados	Contato com material derivados de petróleo	Dermatites, queimaduras, náuseas, dores de cabeça, tonturas e problemas respiratórios.	Uso de EPI' S

Setor:	5. 1 - OPERACIONAL - GHE 2									
Função:	5.1.3 - TRABALHADOR AGROPECUÁRIO POLIVALENTE									
Cargo:	TRABALHADOR AGROPECUÁRIO POLIVALENTE									
Jornada		Repouso		Nº. Funcionários		Faixa Etária				
				Homem	Mulher	< 18	18 a 45	> 45		
8		2		1	0	0	0	1		
Descrição da Função										
Beneficiar produtos agropecuários; cuidar da reprodução de animais; demonstrar competências pessoais; efetuar manutenção na propriedade; manejar área de cultivo; organizar produtos agropecuários para comercialização; preparar solo para plantio; tratar animais.										
EXAMES NECESSÁRIOS										
Risco	Agente	Fonte Geradora	Exame	Periodicidade	Adm.	Após Adm.	Per.	Ret. Trab.	Mud. Risco	Dem.
--	--	--	Hemograma completo	12 meses	X	--	X	X	X	X
--	--	--	Avaliação Clínica Ocupacional	12 meses	X	--	X	X	X	X
Biológico										
Agente		Fonte Geradora			Danos à Saúde			Medidas de Controle		
03.01.002 - Trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros produtos		Contato com Animais						Uso de EPI´ S		
Ergonômico										
Agente		Fonte Geradora			Danos à Saúde			Medidas de Controle		
Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos		Ambiente de trabalho			Lordose, Cífose, Escoliose, Retroversão Pélvica E Retificação Da Coluna Lombar, Flácidez Abdominal.			Pausas regulares e Alongamentos dos membros		

Físico			
Agente	Fonte Geradora	Danos à Saúde	Medidas de Controle
Ruído contínuo ou Intermitente	Motor de trator	Provoca Cansaço, Irritação, Dores De Cabeça, Diminuição Da Audição (Surdez Temporária, Surdez Definitiva E Trauma Acústico), Aumento Da Pressão Arterial, Problemas No Aparelho Digestivo, Taquicardia, Perigo De Infarto.	Uso de EPI´ S

6 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

O Médico Coordenador no âmbito de suas responsabilidades sugere programas especiais para melhor qualidade de vida no trabalho e condições ambientais, tais como:

- Campanha de vacinação
- Palestra sobre DST
- Palestra sobre alcoolismo



Programa	Mês para desenvolvimento sugerido												Data Conclusão	Responsável pela Execução
	2026 / 2027													
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril		
Curso de Primeiros Socorros														
NR - 23 - Brigada de Incêndio														

Os programas serão custeados por CRA - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

7 - RECOMENDAÇÕES À EMPRESA

Prior.	Medidas Propostas	Referência Legal	Metodologia e Ação	Mês para desenvolvimento sugerido												Data Conclusão	Responsável pela Execução
				2026 / 2027													
				Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril		
2	Realização dos exames periódicos, conforme determina o PCMSO.	NR- 07	Em atendimento a NR-07														
5	Fazer o relatório Analítico a cada 12 meses.	NR-07	Em atendimento a NR-07														

As recomendações serão custeadas por CRA - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

7.1 - Orientações e Conduta a Prevenção da COVID-19 (SARS-COV-2)

Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e suas alterações, considerando a Recomendação número 2 – PGT/GT COVID-19 do Ministério Público do Trabalho que considera a COVID-19 como risco ocupacional. Aqui devemos entender risco ocupacional para ações de controle, diminuição e extinção dos riscos e de seus agravos a saúde, não pode ser considerado para efeitos de insalubridade e/ou periculosidade, que para tal determinação continua válido a normatização vigente, a saber, Normas Regulamentadoras número 15 e 16, perícias técnicas...;

Diante do exposto apresentamos abaixo o Protocolo de medidas para a prevenção de casos e surtos de COVID-19 nos ambientes de trabalho, bem como as ações necessárias junto ao esse serviço médico:

- 1).Disponibilizar lavatórios com “*dispenser*” de sabão líquido e papel toalha para que os trabalhadores façam a assepsia das mãos frequentemente durante a jornada de trabalho. A empresa deve disponibilizar também frascos ou “*dispenser*” de álcool gel em todos os setores;
- 2).Estabelecer a higienização das estações de trabalho com álcool a 70% ou outras substâncias de desinfecção antes, durante e após o seu uso. O hipoclorito de sódio 5% pode ser utilizado em pisos,bancadas, maçanetas, torneiras, mesas, etc.;
- 3).Fixar cartazes com as instruções de segurança e prevenção do contágio do SARS-COV-2 em todos os setores da empresa;
- 4).Propor alternativas de jornadas de trabalho, rodízios, férias coletivas ou home office às funções aplicáveis, a fim de diminuir a circulação de pessoas na empresa;
- 5).Estabelecer regra de espaçamento de 2 metros entre as estações de trabalho e os próprios empregados;
- 6).Proceder, através do atendimento clínico de triagem dos trabalhadores que, durante o serviço, apresentarem sintomas gripais, aplicando-lhes a semiologia clínica para diagnóstico de possíveis complicações respiratórias, devendo fornecer as orientações aplicáveis a cada caso;
- 7).Após o atendimento clínico primário, os trabalhadores com sintomas e/ou sinais gripais leves (coriza,mal-estar, tosse seca, febre acima de 37,8º) devem ser orientados a permanecerem em casa e ambos devem comunicar-se entre si. Casos leves devem ser manejados com medidas não-farmacológicas, como repouso, hidratação e alimentação adequada, bem como com analgésicos, antitérmicos e isolamento domiciliar por 14 dias, a contar da data de início dos sintomas;

7.1 – Afastar do trabalho os casos confirmados e suspeitos, e seus contatantes ainda que assintomáticos;

7.2 - Nos casos acima citados, prever a testagem dos trabalhadores para diagnósticos da COVID-19 sem ônus para os empregados;

7.3 – Todo e qualquer empregado afastado por contaminação do COVID-19, após o final da “quarentena”, deverá ser encaminhado para realização do exame de retorno ao trabalho, independente da duração do período de afastamento;

7.1 - Orientações e Conduta a Prevenção da COVID-19 (SARS-COV-2)

7.3.1 – O exame de retorno ao trabalho será composto de anamnese clínica e realização de demais exames necessários para elucidação do diagnóstico;

7.4 - Nos casos de mudança de risco o trabalhador afastado por COVID-19 ou não, deverá realizar o exame antes da alteração de função, para verificação da condição física e mental do trabalhador para o desempenho das novas funções, bem como os riscos ocupacionais identificados no PGR.

7.5 – Todo e qualquer atendimento clínico e/ou afastamento relacionado a COVID-19, inclusos ou não nos casos acima, deverá ser enviado a documentação clínica e de ações de controle para esse serviço médico, afim de tomarmos as devidas providências incluindo a atualização de prontuários;

7.6 - O médico do trabalho poderá indicar afastamento do trabalhador com diagnóstico de COVID-19, ainda que o teste consigne resultado “não detectável”, mas estejam presentes elementos para a confirmação clínico-epidemiológica do caso, assim como trabalhadores com suspeita de infecção pelo agente biológico da doença, ainda que assintomáticos, bem como dos contatantes dos casos suspeitos e confirmados no ambiente de trabalho;

8).Em caso de sintomas e sinais respiratórios mais severos (febre persistente ou muito alta e falta de ar), o empregado deverá procurar imediatamente a uma Unidade de Saúde que faça o protocolo de procedimentos diagnósticos para a COVID-19;

10).Vetar qualquer aglomeração de trabalhadores ou pessoas em salas de espera, refeitórios... ou quaisquer outros ambientes da empresa;

11). Esclarecer aos trabalhadores, em linguagem simples e objetiva, sobre a eficácia do isolamento social e seguir rigidamente as normas sanitárias e de biossegurança;

12). Esclarecer aos trabalhadores a imperiosa necessidade de realizar a lavagem das mãos com água e sabão com frequência e sobre a indicação e uso consciente do álcool gel;

13). Proceder ao imediato afastamento dos trabalhadores pertencentes ao grupo de risco (como idosos com mais 60 anos; cardiopatas; pacientes com diabetes, doenças respiratórias moderadas a severas ou em tratamento recente de câncer; gestantes) para tanto esse serviço médico deverá ser informado das alterações do quadro;

14). Treinar e capacitar todos os trabalhadores sobre os procedimentos a serem adotados em cada situação, em conformidade com o Ministério da Saúde;

8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A efetividade do P.C.M.S.O. é responsabilidade de todos os envolvidos na empresa, cabendo ao médico coordenador a Assessoria técnica e científica, exigindo do empregador suporte humano e material para a garantia da saúde físico-psíquico-social do trabalhador, respeitando os Indicadores de Tolerância Biológica. Para efeito de cumprimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional serão considerados os seguintes critérios, de acordo com a NR n° 7:

1º - Sendo verificada, através da avaliação clínica do trabalhador e/ou dos exames constantes do Quadro I, apenas exposição excessiva ao risco mesmo sem qualquer sintomatologia ou sinal clínico, deverá o trabalhador ser afastado do local de trabalho, ou do risco, até que esteja normalizado o Indicador Biológico de Exposição e as medidas de controle nos ambientes de trabalho tenham sido adotadas.

2º - Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais através de exames médicos que incluam os definidos nesta NR; ou sendo verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico, através de exames constantes dos Quadro I (com interpretação SC) e II, e do item 7.4.2.3 da presente NR, mesmo sem sintomatologia, caberá as Seguintes Medidas:

- a) Solicitar a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT;
- b) Quando necessário, o afastamento do trabalhador, da exposição ao risco, ou do trabalho;
- c) Encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexo causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho;
- d) O empregador quando necessário medidas de controle no ambiente de trabalho.

Primeiros Socorros:

Esta empresa deverá estar equipada com material necessário à prestação de primeiros socorros, considerando as características das atividades desenvolvidas e a orientação do médico coordenador, mantendo este material guardado em local adequado, visível e aos cuidados de pessoas treinadas para este fim.



Curso de Noções de Primeiros Socorros.

Enfatizando e destacando as prioridades abaixo elencadas.

1º O atendimento pré-hospitalar de primeiros socorros deve ser efetuado prioritariamente por médico ou por uma equipe treinada e com supervisão médica a distância.

2º Na impossibilidade da(s) vítima(s) serem atendidas por equipe paramédica treinada ou por médico, o colaborador socorrista recebeu noções básicas de:

- Desobstruir as vias aéreas da vítima, permitindo que possa voltar a respirar;
- Estancar hemorragias externas pela compressão do foco de sangramento como gaze ou tecido limpo
- Imobilizar fraturas de membros improvisando tala com madeira ou jornal visando exclusivamente evitar a movimentação do foco da fratura.
- Proteção da coluna cervical e lombar, imobilizando a com colar cervical quando disponível e usando maca do tipo tabua com o objetivo de evitar qualquer movimentação de possível fratura da coluna vertebral.
- Manter limpas e protegidas áreas corporais expostas por queimadura.
- Dar apoio emocional a vítima enquanto é aguardado transporte por equipe de resgate.

Considerações Finais.

A Organização se compromete a atualizar este documento quando acontecerem quaisquer alterações que envolva mudanças de:

- Atividades
- Leiautes
- Máquinas e Equipamentos
- Ferramentas
- Casos de acidentes
- Doenças relacionadas ao Trabalho (B-91)
- Princípios de Incêndio
- Alterações de Riscos ou possíveis agravos a saúde
- Outras mudanças

Por fim é de meu conhecimento que a prestação de informações falsas constitui crime de falsificação de documento público, nos termos do artigo 297 do Código Penal.



9 - NOMEAÇÃO DE MÉDICOS AVALIADORES

Conforme as diretrizes da Norma Regulamentadora n.º 7 da portaria n.º 24 de 29 de dezembro de 1994 e suas atualizações o Médico Coordenador baseado no item 7.3.2. da referida NR nomeia como Médicos Avaliadores para Empresa

Ana Emilia Pessoa Garcia - CRM 705

10 - ENCERRAMENTO E PROTOCOLO

Segue este Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional composto de 30 páginas de material descritivo e orientativo, devidamente rubricada e assinada por :



Ana Emilia P. Garcia
Médica
CRM-TO 705

Ana Emilia Pessoa Garcia
Médico(a) Responsável do PCMSO - Especialista
em Medicina do Trabalho
CRM 705 TO - CPF: 203.481.004-00

De Acordo:

Nome e Assinatura Empresa

ANEXOS

1 - Tabela de Máxima Exposição Diária Permitida ao Ruído

A legislação vigente sobre o assunto - Norma Regulamentadora 15 da Portaria n.º 3214/78 do Ministério do Trabalho, através do Anexo n.º 1, fixa os limites de tolerância para exposição a ruído contínuo ou intermitente, sem a adequada proteção, que abaixo se transcreve.

NÍVEL DE RUÍDO dB(A)	MÁXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA PERMISSÍVEL
85	8 horas
86	7 horas
87	6 horas
88	5 horas
89	4 horas e 30 minutos
90	4 horas
91	3 horas e 30 minutos
92	3 horas
93	2 horas e 40 minutos
94	2 horas e 15 minutos
95	2 horas
96	1 hora e 45 minutos
98	1 hora e 15 minutos
100	1 hora
102	45 minutos
104	35 minutos
105	30 minutos
106	25 minutos
108	20 minutos
110	15 minutos
112	10 minutos
114	8 minutos
115	7 minutos

ANEXOS

2 - Kit de primeiros socorros

Material necessário à prestação de primeiros socorros (ferimentos, queimadura em geral, intoxicações, envenenamento, desmaios, convulsões, males súbitos, etc.) e equipamentos para procedimentos ambulatoriais.

- Algodão Hidrófilo
- Ataduras de crepe;
- Caixa de curativo adesivo (band aid)
- Colar cervical (somente em ambulatório com enfermagem);
- Esfigmomanômetro (somente em ambulatório com enfermagem);
- Esparadrapo;
- Tesoura sem ponta;
- Estetoscópio (somente em ambulatório com enfermagem);
- Gazes esterilizadas;
- Luvas esterilizadas e de procedimentos
- Micropore Largo
- Soro Fisiológico 0,9%;

Observações:

Em local onde haja médico avaliador este solicitará sua própria lista, se assim desejar;

O material deve ser guardado em local adequado e de fácil acesso, aos cuidados de pessoas devidamente treinadas.